

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ

Γενικά: Οι Πυρετικοί Σπασμοί (ΠΣ), αποτελούν την πλέον κοινή αιτία ευκαιριακών σπασμών στην παιδική ηλικία. Πρόκειται για μια συχνή και καλοήγη κατάσταση, που δεν δικαιολογεί πανικό ούτε εκ μέρους των γονιών, ούτε κι από τον ιατρό. Παρ' όλα αυτά κάθε παιδί με πυρετικούς σπασμούς πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς, αλλά και να διερευνάται κατάλληλα για την πιθανότητα σοβαρής υποκρυπτόμενης οξείας λοίμωξης, όπως σήψη ή οξεία μηνιγγίτιδα, καθώς και σοβαρών ηλεκτρολυτικών διαταραχών, ιδιαιτέρως αν πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο πυρετικών σπασμών.

Η συχνότερη ηλικία εμφάνισης των πυρετικών σπασμών είναι η ηλικία μεταξύ 6 μηνών και 3 ετών, με αιχμή εμφάνισης τους 14-20 μήνες. Είναι εξαιρετικά συχνοί και εμφανίζονται σε ποσοστό έως και 4% των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Συνήθως υπάρχει θετικό ιστορικό σπασμών στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον (γονείς, αδέρφια) στο 25-40% των περιπτώσεων.

Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία πυρετού που σχετίζεται με την εμφάνιση πυρετικών σπασμών. Από τους ιούς, οι πλέον συχνοί, σχετιζόμενοι με εμφάνιση πυρετικών σπασμών, θεωρούνται οι ερπητοϊοί (HHV-6) και οι ιοί της ινφλουένζας Α και Β.

Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης πυρετικών σπασμών υπάρχει κατά τις πρώτες 3 ημέρες μετά την 1^η δόση του εμβολιασμού με το εμβόλιο DTaP και κατά τις πρώτες 3-12 ημέρες μετά την 1^η δόση του εμβολιασμού με το εμβόλιο MMR ή MMRV, για παιδιά από 12-24 μηνών που κάνουν στην ηλικία αυτή την 1^η δόση.

Κλινική εικόνα: Η πλειονότητα των παιδιών που εμφανίζει ένα επεισόδιο ΠΣ παρουσιάζει φυσιολογική ψυχοκινητική και νευρολογική ανάπτυξη. Ο ουδός της θερμοκρασίας που πιθανώς να πυροδοτήσει επεισόδιο ΠΣ είναι μοναδικός για κάθε ασθενή. Συνήθως οι ΠΣ εκλύονται επί απότομων αυξήσεων της θερμοκρασίας σε επίπεδα μεγαλύτερα από 38 °C, κατά τη διαδρομή κοινών εμπύρετων λοιμώξεων, όπως οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, η μέση ωτίτιδα, οι λοιμώξεις του γαστρεντερικού, το αιφνίδιο εξάνθημα, κ.λπ.

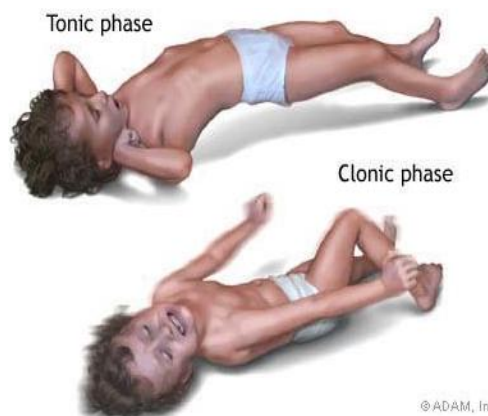
Η πλειονότητα των πυρετικών σπασμών διαρκούν λιγότερο από 4-7 λεπτά.

Εμφανίζουν γενικευμένη τονικοκλονική ή τονική δραστηριότητα και λύνονται αυτόματα.

Ως απλοί ΠΣ, χαρακτηρίζονται οι σπασμοί οι οποίοι προσβάλλουν το 2-5% των παιδιών χωρίς ιστορικό νευρολογικών προβλημάτων, ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών. Είναι γενικευμένοι, διάρκειας μικρότερης των 15 λεπτών, που δεν υποτροπιάζουν εντός 24 ωρών, συνοδεύονται πάντα από πυρετό υψηλότερο από 38° C ή από ιστορικό πρόσφατου πυρετού και κατά την κλινική εξέταση δεν ανευρίσκονται σημεία λοίμωξης του ΚΝΣ (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα). Γενικά, εμφανίζουν καλή πρόγνωση. Περίπου το 1/3 των παιδιών με προηγούμενο πυρετικών σπασμών παραμένει σε αυξημένο κίνδυνο επαναλαμβανόμενων πυρετικών σπασμών.

Οι επιπλεγμένοι ΠΣ, διαρκούν περισσότερο από 15 λεπτά, μπορεί να είναι εστιακοί και υποτροπιάζουν συχνά στο πρώτο 24ωρο ή κατά την ίδια εμπύρετη λοίμωξη, ενώ μπορεί να αφήσουν μετακριτική πάρεση Todd (αίσθημα κόπωσης και καταβολής με έντονη υπνηλία που μπορεί να διαρκέσει λεπτά ή ώρες) και συχνά μπορεί να συνυπάρχει νευρολογικό υπόβαθρο ή αναπτυξιακή καθυστέρηση. Στο 3-4% μπορεί να καταλήξουν σε χρόνια επιληψία.

Διαφορική διάγνωση: Στη Δ/Δ περιλαμβάνονται: το ρίγος, το πυρετικό παραλήρημα, η κρίση κατακράτησης της αναπνοής, οι σοβαρές λοιμώξεις (σήψη), οι λοιμώξεις του ΚΝΣ (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα), η ΚΕΚ, το τραύμα, η υπογλυκαιμία, η γενικευμένη και η εστιακή επιληψία, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές ($\text{Na}^+/\text{Ca}^{++}/\text{Mg}^{++}$), οι δηλητηριάσεις, οι αναπτυξιακές διαταραχές, οι διαταραχές μεταβολισμού των αμινοξέων (PKU, MSUD, νόσος Hartnup), κ.ά.



© ADAM, Inc.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Σε κάθε παιδί με πυρετό, αρχικά, είναι σημαντικό να γίνεται εκτίμηση απειλητικών για τη ζωή συμπτωμάτων και για την παρουσία σοβαρής ασθένειας. Θα πρέπει να εκτιμηθεί η βατότητα του αεραγωγού (Α), η αναπνοή (Β), το κυκλοφορικό σύστημα (C) και το επίπεδο συνείδησης (D). Παράλληλα εκτιμάται η καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία, ο χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης, η σπαργή δέρματος, η θερμοκρασία των άκρων.
2. Η εκτίμηση του πυρετού πρέπει να αξιολογείται παράλληλα και με άλλες παραμέτρους, όπως η γενική κατάσταση του παιδιού, το χρώμα του δέρματος, το επίπεδο συνείδησης, η επικοινωνία και η δυνατότητα να ξυπνάει εύκολα, η ενυδάτωση, η σίτιση και κυρίως η ταχυκαρδία. Εισαγωγή στο νοσοκομείο και διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης (ΟΝΠ) επιβάλλεται επί παρουσίας μηνιγγικών σημείων, καθώς και στους ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά τις προηγούμενες ημέρες, πριν το επεισόδιο των σπασμών, λόγω της πιθανότητας κάλυψης των μηνιγγικών σημείων. Επίσης, εισαγωγή σε παιδιατρική κλινική και ΟΝΠ απαιτείται σε ασθενείς ηλικίας < 18 μηνών, ενώ στα παιδιά ηλικίας > 18 μηνών δεν χρειάζεται η διενέργεια της ΟΝΠ εφόσον είναι σε καλή γενική κατάσταση.
3. **Αντιπυρετικά σκευάσματα** χρησιμοποιούνται συστηματικά σε παιδιά με πυρετό και με ιστορικό πυρετικών σπασμών, αφ' ενός για να ελαττώσουν τον πυρετό και αφ' ετέρου να ελαττώσουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης ή υποτροπής του επεισοδίου σπασμών.
Η συνήθης κλινική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων (**Παρακεταμόλη, Μεφαιναμικό οξύ, Τολφαιναμικό οξύ και Ιβουπροφαίνη**), με βάση το βάρος (ΒΣ), και όχι την ηλικία του ασθενούς, καθώς και τη συμπληρωματική εφαρμογή φυσικών μεθόδων ψύξης (λουτρό, δροσερά επιθέματα-κομπρέσες, ελαφρά ένδυση).
Η χορήγηση Παρακεταμόλης ή Ιβουπροφαίνης, ως μονοθεραπεία, είναι το προτεινόμενο σχήμα, ενώ η συνδυασμένη εναλλάξ χορήγησή τους προτείνεται μόνον εφόσον υπάρχει συνεχιζόμενη κακουχία και εμμένων υψηλός πυρετός. Έτσι, ως αντιπυρετικά, χορηγούμε:
 - ♦ **Παρακεταμόλη** (σιρόπι 120 ml: *Apotel/Depon/Panadol*: 120 mg/5 ml). Χορηγείται σε δόση 10-15 mg/kg ΒΣ κάθε 4-6 ώρες, με μέγιστη δόση 1 g/24ωρο. Πρακτικά, στη δόση χορηγούμε το μισό του σωματικού βάρους σε ml, για τα σκευάσματα των 120 mg/5 ml.
 - ♦ **Μεφαιναμικό οξύ** (σιρόπι 150 ml: *Rafreda* 250 mg/5 ml & caps./supp. *Ponstan* 500 mg). Χορηγούνται 5 mg/kg ΒΣ (ΒΣ/2), κάθε 4-6 ώρες, συνήθως εναλλάξ με Παρακεταμόλη.
 - ♦ **Τολφαιναμικό** (σιρόπι 125 ml: *Gantil* 10 mg/5 ml). Δόση του φαρμάκου σε ml: ΒΣ/2.
 - ♦ **Ιβουπροφαίνη** (σιρόπι 150 ml: *Algofren* 100 mg/5 ml, *Nurofen* 200 mg/5 ml). Διαθέτει ισχυρότερη αντιπυρετική δράση και αντιμετωπίζει καλύτερα την παιδική ανησυχία και κακουχία. Χορηγείται σε δόση 10 mg/kg ΒΣ, κάθε 6 με 8 ώρες, μέχρι συνολικής δόσης 1200 mg/24ωρο. Πρακτικά, η κάθε δόση του φαρμάκου είναι το μισό του βάρους σε ml (δόση σε ml: ΒΣ/2) για το σιρόπι των 100 mg/5 ml. Η χορήγηση Ιβουπροφαίνης πρέπει να αποφεύγεται σε παιδιά με σοβαρή αφυδάτωση, διότι συνδέεται με νεφροτοξικότητα και επιπλέον συστήνεται να χορηγείται σε παιδιά μεγαλύτερα των 3 μηνών.
4. Η **Φαινοβαρβιτάλη** (syr. 30 ml: *Kaneuron* 54 mg/ml). Χορηγείται και ως δόση εφόδου 18-20 mg/kg, im ή iv εντός 100 ml N/S, στάγδην σε 10 λεπτά και είναι αποτελεσματική στην πρόληψη των πυρετικών σπασμών, αλλά παρουσιάζει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υπερκινητικότητα, ευερεθιστότητα και πιθανόν απώλεια γνωστικών λειτουργιών.
5. Το **Βαλπροϊκό οξύ** (syr. 300 ml: *Depakine* 200 mg/5 ml) είναι το ίδιο αποτελεσματικό με τη Φαινοβαρβιτάλη στην πρόληψη των πυρετικών σπασμών, αλλά έχει ενοχοποιηθεί για θρομβοπενία, ηπατοξικότητα, γαστρεντερικές διαταραχές και παγκρεατίτιδα.
6. Κατά την έξοδο απ' το Νοσοκομείο ή το ΚΥ, συνιστούμε στους κηδεμόνες την προμήθεια υπόθετων **Διαζεπάμης** (supp. *Stesolid* 5 mg) ή/και το υπογλώσσιο/ενδοπαρειακό διάλυμα **Μιδαζολάμης** 0,2-0,5 mg/kg ΒΣ (oral. sol. *Epistatus* 10 mg/ml), το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση επόμενου επεισοδίου πυρετικών σπασμών του παιδιού.